PLANO DE ANÚNCIOS PARA CONSULTÓRIO · VERSÃO DE 04/11/2026

Como eu faria seus anúncios de Cardiologia

Plano para quem tem consultório próprio, continuando o carrossel: a conta, a verba, as campanhas, os criativos e o combinado com a recepção, para cardiologia.

1 A conta da consulta, antes de qualquer anúncio

Clínica não compra conversa. Clínica compra paciente sentado na cadeira. Por isso a primeira coisa que eu faria é esta conta, com os seus números.

1 O valor da consulta que você cobra

2 menos o que ela custa para você (equipe, aluguel, imposto) = o que sobra

3 Valor da consulta ÷ o que sobra = quanto cada R$ 1 de anúncio precisa voltar para empatar

EXEMPLO, NÃO É NÚMERO SEU

Consulta de R$ 400, sobram R$ 200	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 2**
Com 25% de desconto: consulta de R$ 300, sobram R$ 100	**cada R$ 1 precisa voltar R$ 3**
R$ 1.000 de verba a R$ 10 por conversa = 100 conversas	**16 consultas realizadas, R$ 6.400 em consultas de R$ 400 (se 40% agendam e 40% comparecem)**

Seus números: consulta R$ _____ · sobra R$ _____ · cada R$ 1 precisa voltar R$ _____

Os 40% são benchmark de mercado (funil 40/40/40, do método de Pedro Sobral): de 100 conversas, 40 agendam, 16 comparecem e 4 fecham tratamento ou procedimento. Serve só para abrir a conversa. Com 60 a 90 dias de campanha, vale o número da sua conta, e só ele.

O que entra na conta nesta especialidade

Cardiologia costuma ter consulta de valor mais alto e exames que nascem da consulta, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, MAPA e Holter. Conte o exame só se você o realiza. Se encaminha para fora, a conta é a consulta e o retorno.

2 Onde colocar a verba

Google
vai quem tem urgência. O paciente já está procurando e escolhe quem aparece e responde primeiro.

Meta (Instagram e Facebook)
vai quem tem ticket e precisa de confiança. Antes de vender o preço, eu preciso vender o médico.

Notoriedade
médico já conhecido na cidade rende no Google mesmo com ticket alto.

META PESA MAIS

Há dois pacientes. O assustado, com palpitação ou falta de ar, pesquisa o sintoma. O que adia, com pressão alta no remédio, histórico na família ou check-up que nunca fez, precisa ser lembrado e convencido. Esse segundo grupo decide por confiança. Eu colocaria a maior fatia na Meta e deixaria o Google em sintoma, em nome e em cidade.

A fatia exata de cada lado eu só fecho com 60 a 90 dias de dado da sua conta. Aqui está o ponto de partida.

3 As 3 campanhas do Google

Volume de busca e custo por clique eu não medi para a sua cidade. Tudo abaixo é para testar, não é dado. Eu começaria em correspondência exata, e abriria para frase só se a exata não gastar a verba.

1. Nome do médico

Quem já ouviu falar de você e vai conferir. Teto de R$ 30 por dia.

- dr. / dra. [seu nome]
- [seu nome] [cidade]
- [nome da clínica] [cidade]

2. Especialidade + cidade

Quem já sabe qual médico procura e está comparando.

- cardiologista [cidade]
- cardiologista particular [cidade]
- consulta cardiológica [cidade]
- check-up cardiológico [cidade]
- eletrocardiograma [cidade]
- ecocardiograma [cidade]

3. Sintoma

Quem ainda não sabe qual médico resolve. Ele pesquisa o que sente.

- palpitação
- coração acelerado
- falta de ar ao subir escada
- pressão alta o que fazer
- tontura e pressão alta
- inchaço nas pernas
- dor no peito ao esforço

Negativar de saída: "chá", "remédio caseiro", "curso", "concurso", "grátis", "SUS".

> Busca por "dor no peito" pode ser emergência. O texto do anúncio dessa busca começa orientando ligar 192 ou ir ao pronto-socorro se a dor for forte, e só depois oferece a consulta.

Destino do clique: o WhatsApp da recepção ou uma página curta com preço, forma de pagamento e endereço. O clique no botão de WhatsApp é a conversão que eu marco.

4 Público e sequência na Meta

Público

Adultos da cidade e do raio, e um público à parte: a filha ou o filho adulto que cuida dos pais. O criativo para quem toma remédio de pressão é diferente do criativo para quem nunca fez check-up.

MÊS 1

70% no topo

70% da verba vai para quem ainda não conhece o seu nome, com vídeo que tira dúvida. Os 30% restantes vão para o anúncio de consulta, com preço e forma de pagamento, para quem já viu o vídeo.

Os dois primeiros vídeos do mês são a pressão que está no remédio mas não está acompanhada e o check-up do coração para quem não sente nada.

MÊS 2 EM DIANTE

60% em remarketing

60% da verba vai para quem já conhece você: quem chamou no WhatsApp (180 dias), quem visitou o site (90 dias) e quem assistiu aos vídeos (30 dias). O topo continua rodando com o resto.

Quem chamou e não marcou vê o vídeo do que acontece no check-up, com valor. Quem assistiu ao vídeo de pressão vê o anúncio de consulta com horários.

Eu não mexo numa campanha em menos de 72 horas e olho o mês, não o dia. Eu reporto duas medidas lado a lado: conversa iniciada e segunda mensagem enviada. Só a primeira infla.

5 3 ângulos de criativo

Cada um filtra um paciente. Atenção sem filtro traz curioso, e curioso encarece a conversa.

Remédio não é acompanhamento

"Tomar o remédio da pressão todo dia não é o mesmo que ter a pressão acompanhada."

Vídeo do cardiologista. Filtra o hipertenso que só renova receita.

Para quem cuida do pai

"O seu pai nunca fez um check-up do coração? Quem marca pode ser você."

Reel ou carrossel para filhos adultos. Abre um público que o anúncio direto não alcança.

Cansaço que parece idade

"Cansaço ao subir escada que você atribui à idade pode ser só isso. Vale confirmar com um exame."

Vídeo que nomeia o sintoma sem fazer diagnóstico e sem medo.

6 5 dúvidas de paciente para virar conteúdo

1. "Palpitação é perigosa?"
2. "Pressão 12 por 8 é normal?"
3. "Preciso fazer check-up do coração se não sinto nada?"
4. "Colesterol alto dá sintoma?"
5. "Posso fazer academia tendo problema no coração?"

Cada dúvida vira um vídeo ou carrossel. Toda resposta com número ou critério precisa de fonte que você possa citar. Sem fonte, tira o número e fica o raciocínio.

7 O combinado com a recepção

Eu trabalho com 20 minutos como limite de resposta: quem tem dor costuma chamar mais de um consultório e fecha com quem responde primeiro e já oferece horário.

Quem responde	Em quanto tempo	O que a IA pode fazer sozinha

A primeira resposta, por escrito

Repetir o que a pessoa pediu, informar o valor e oferecer dois dias e horários. Cadastro e reserva vêm depois da escolha.

Pergunta inicial: "O motivo é check-up, controle de pressão ou algum sintoma agora?"

Urgência e encaixe

Dor forte no peito, falta de ar em repouso ou desmaio: a recepção não oferece horário. Orienta ligar 192 ou ir ao pronto-socorro.

Peça que o paciente traga os exames e eletrocardiogramas anteriores. Na confirmação, mande o endereço e a orientação de preparo do exame, se houver.

Automático pode ser o aviso de recebimento, a pergunta inicial e o lembrete de horário. Preço, horário e qualquer orientação de saúde saem de uma pessoa ou de um texto que você já aprovou.

8 O que eu NÃO faria, pelo conselho

Base: Resolução CFM 2.336/2023, a vigente. Ela permite informar preço, forma de pagamento e desconto. Continua fora:

- Promessa de resultado, em qualquer forma.
- Antes e depois.
- Nota, estrela ou print de avaliação.
- Chamar alguém de especialista sem o RQE registrado.
- Escassez que não existe. "Últimos horários" só se a agenda estiver fechando de verdade.

Nesta especialidade, o risco mais comum

- Texto de medo, como "o infarto pode estar chegando".
- Promessa de prevenir infarto ou de curar a pressão alta.
- Antes e depois, inclusive de exame, e print de avaliação com nota ou estrela.
- Colocar "cardiologista" no título sem o RQE. Sem ele, use "médico" e descreva a área em que atende.

Antes de subir qualquer anúncio, o texto passa por revisão. Este plano não substitui a leitura da resolução pelo responsável técnico.

E antes da conversa chegar?

O plano cuida do anúncio e da recepção. O Raio-X olha o passo anterior: como o seu consultório aparece hoje no Google e na IA. Leva poucos minutos.

Fazer o Raio-X do meu consultório